EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 92390
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-09-09 12:29:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JOVITA MARIA FUENTES ACUNA			RUN	: 5.700.503-3
F.Nac	: 07-03-1942	Edad	: 82 AÑOS, 6 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: PUELMA 237			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 971352483		
Fecha Ingreso	: 2024-08-22	Fecha Egreso	: 2024-09-09 12:29:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico territorio ACM derecho superficial total y profundo parcial
-Oclusión en tándem M1 derecha
-Pseudooclusión ACI izquierda
-Fibrilación auricular crónica sin TACO
-Hipernatremia resuelta
-Sd diarreico, obs 2° a alimentación enteral (CD/LF/coprocultivo negativos) resuelto
-ITU alta resuelta. Urocultivo(+) S. aureus y E faecalis. ATB ampicilina 7/7, ciprofloxacino 6/6. CAT(-)
-AKI en regresión parcial
-Ant: HTA - DM2 - HDA 2° úlcera gástrica Forrest II + gastropatía erosiva (marzo/24) - ACV antiguo secuelado con hemiparesia BC izquierda? - mRS 2-3

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente REG, HDN estable estable, FA al monitor s/RVR, eupneica, afebril en últimas 96h, tolera bien alimentación por SNG, no refiere molestias, menos confusa que días previos.
Diuresis(+) dep(-), sin diarrea últimas 96h.
TC cerebro muestra infarto completo de territorio superficial y profundo de ACM derecho, con leve efecto de masa sobre VL ipsilateral, sin hidrocefalia ni TH.
TC tórax s/c no muestra imágenes sugerentes de neumonía, se observa cardiomegalia global con dilatación auricular bilateral y calcificación de válvula mitral, sin derrame pleural, traquea y bronquios principales permeables, posible congestión a nivel de cisuras izquierdas.
AngioTC cerebro y cuello: oclusión en tándem M1 derecha y pseudooclusión ACI izquierda, infartos antiguos cerebeloso y occipital izquierdos, microangiopatía Fazekas 3.
Exs de lab de control muestran ELP N, fx renal en regresión parcial, PCR estacionaria baja.
Completó tto ATB tto por ITU.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio hoy con HODOM para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica, y control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-15 días.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy con HODOM para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-15 días

INDICACIONES AL ALTA

1. -Atorvastatina 40 mg/noche
2. -Amlodipino 10 mg/día
3. -Carvedilol 6.25 mg c/12 horas
4. -Clopidogrel 75 mg/día
5. -Famotidina 40 mg/noche

EXÁMENES Y RESULTADOS

9/9/24
-Crea 1.1 MDRD 47.55 Uremia 46
-Na 139 K 4.1 Cl 107
-PCR 32

6/9/24
-Crea 1.2 MDRD 43.01 Uremia 74
-Na 137 K 3.7 Cl 106

5/9/24
-Alb 2.7
-Crea 1.3 MDRD 39.21 Uremia 84
-AU 2.9
-Ca 8.7 Ca corr 8.7 Na 137 K 4.2 Cl 106

2/9/24
-Alb 2.7
-Crea 1.3 MDRD 39.21 Uremia 113
-AU 2.8
-Ca 8.7 P 2.8
-FA 145 BI 0.35 BD 0.35 BT 0.7 GOT 146 GPT 123 GGT 61
-PCR 36.9
-Na 151 K 5 Cl 121
-Leu 13100 Hb 11.5 Plaq 159000 Seg 88 VHS 60
-Procal 0.13

31/8/24
-Crea 1.2 MDRD 43.01 Uremia 105
-PCR 23.9
-Mg 2.1 Na 146 K 3.1 Cl 114

30/8/24
-Crea 1.1 MDRD 47.55 Uremia
-PCR 23
-Ca 8.1
-Na 143 K 3.2 Cl 114
-LF(-) CD(-) Coprocultivo(-)

29/8/24
-Alb 2.6
-Crea 1.1 MDRD 47.55 Uremia 106
-AU 3.5
-Ca 7.9 Ca corr 9
-PCR 28.9
-Na 141 K 3.1 Cl 109
-Leu 10900 Hb 12 Plaq 162000 Seg 70 VHS 54
-Procal 0.32

28/8/24
-Crea 1.2 MDRD 43.01 Uremia 120
-PCR 55.6
-Na 151 K 3.6 C 111

-Leu 11400 Hb 12.4 Plaq 165000 Seg 81 VHS 59
-INR 15.9 DD 9847
-Hb glic 5.9

26/8/24
-Crea 1.2 MDRD 43.01 Uremia 93
-PCR 51
-Na 149 K 3.7 Cl 107
-Hb glic 14600 Hb 12.8 Plaq 169000 Seg 90 VHS 86
-Procal 0.5

24/8/24
-Alb 2.9
-Crea 1.2 MDRD 43.01 Uremia 50
-AU 3.2
-Ca 9.1 P 2.3 Mg 1.9 Na 141 K 3.6 Cl 109
-FA 107 BI 0.85 BD 0.15 BT 1 GOT 43 GPT 19 GGT 25
-LDH 370
-Lact 1.1
-PCR 7.4
-Leu 11400 Hb 12.1 Plaq 221000 Seg 76 VHS 80
-INR 1.31
-B12 345 Folato 13.1
-Procal 0.06
-GSA pH 7.46 CO2 39 HCO3 28.2

23/8/24
-Na 140 K 4.1 Cl 111

23/8/24
-ColT 133 HDL 65 LDL 52 VLDL 16.2 TG 81
-TSH 2.959 T4L 1.18
-OC N

22/8/24
-Glic 141
-Alb 3.5
-Crea 1.2 MDRD 43.01 Uremia 37
-CKMB 28 CK 372
-LDH 399
-Lact 1.3
-Na 139 K 4.3 Cl 104
-Hb 12.4 leu 5900 Plaq 209000 Seg 62
-INR 1.93 TTPA 31
-Trop 12.8

OBSERVACIONES:

Ex fco gral:
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-), sin secreción conjuntival
-Cardiaco: RII 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) sibilancias espiratorias bilaterales escasas, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas ni visceromegalia
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos +/+

Ex neurológico:
-Mental: vigil, confusión leve, orientada sólo en tiempo, lenguaje N, distingue derecha-izquierda cruzando linea media
-PC: CV por amenaza impresiona hemianopsia izquierda, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC izquierda moderada, disartria leve, nistagmo(-), úvula central, elevación palatina simétrica,
lengua desviada a izquierda

-Motor: BC der M5, ESI M2, EII M3, RCP extensor bilateral
-Sensibilidad: algesia impresiona conservada en las 4 EE
-Cerebelo: n/e
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO